

Protocolo base de ultrasonido terapéutico

CÓDIGO	ULT-P01	VERSIÓN	02	FECHA	___ / ___ / ____
--------	---------	---------	----	-------	------------------

Documento base editable para fisioterapeuta independiente en consultorio intramural. Debe adaptarse, adoptarse y acompañarse de evidencias reales antes de evaluar cumplimiento. Responsable del proceso [nombre del profesional].

1 Objetivo y aplicabilidad

Ultrasonido con equipo identificado y técnica dentro de formación y oferta registrada. Adoptar únicamente si se oferta. Completar población, alcance y guía clínica seleccionada antes de uso; este documento es un protocolo base adaptable.

2 Responsable y recursos

Fisioterapeuta [nombre], con competencia acreditada. Área con privacidad según técnica, camilla o espacio seguro, equipos e insumos identificados en inventario. Registrar referencia exacta de manual o guía, fecha y versión.

3 Evaluación previa

Revisar indicación, tejido y región, integridad cutánea, sensibilidad y contraindicaciones específicas. Distinguir ultrasonido terapéutico de diagnóstico; no incorporar procedimientos no incluidos en competencia.

4 Información y preparación

Confirmar identidad, explicar intervención, riesgos relevantes y alternativas; documentar consentimiento mediante mecanismo válido. Verificar higiene, seguridad del entorno y disponibilidad de elementos. Registrar medidas iniciales que permitan valorar resultados.

5 Ejecución individualizada

Elegir frecuencia, modo, intensidad, ciclo de trabajo, duración, área y acoplamiento según equipo, evaluación y evidencia. Comprobar cabezal y medio de acoplamiento; ejecutar movimiento y técnica conforme al fabricante. Registrar parámetros reales.

6 Suspensión y seguimiento

Vigilar dolor e incomodidad; detener ante reacción inesperada, falla de equipo o deterioro. Reevaluar utilidad y resultado. Mantenimiento y verificación técnica deben respaldar funcionamiento; no suponer eficacia por encender el equipo.

7 Registro y adopción

Diligenciar parámetros, respuesta, eventos, educación y siguiente conducta en historia clínica autenticada. Definir criterios específicos de ingreso y egreso y anexar evidencia seleccionada por el profesional. No presentar el borrador como guía validada sin revisión clínica y adaptación al equipo.

Formatos de registro

Diligenciar con datos reales. Usar No aplica con justificación cuando corresponda. Reproducir cada ficha según necesidad. No incluye campos de firma.

ULT-F01 Intervención y seguimiento

Campo	Información
Paciente fecha hora y objetivo	_____
Evaluación precauciones y consentimiento	_____
Técnica equipo o recursos	_____
Parámetros y dosis individualizada	_____
Respuesta antes durante y después	_____
Educación y plan siguiente	_____
Autor y referencia de autenticación	_____

Lista de verificación interna

ULT-F04 • Fecha [completar] • Auditor por nombre [completar]

Registrar C cumple, NC no cumple, NA no aplica o PV pendiente de verificar. C exige evidencia observada; NA exige fundamento. Esta lista orienta la preparación y no reproduce todos los criterios de la autoevaluación oficial.

Punto de control	Estado	Evidencia y observación
Técnica coincide con oferta y competencia	_____	_____
Guía y manual identificados	_____	_____
Precauciones valoradas	_____	_____
Parámetros individualizados registrados	_____	_____
Respuesta y suspensión documentadas	_____	_____

Registro de hallazgos

Hallazgo y criterio	Acción y responsable	Plazo y eficacia
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Referencias y límites

Base de organización: Resolución 3100 de 2019, manual anexo, criterios generales aplicables y apartado 11.3.1 Servicio de terapias, con modificaciones vigentes. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026. Consulta de fuentes 3 de octubre de 2026. Verificar el instrumento territorial vigente antes de radicar.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576